

8. PALPAREA ABDOMENULUI PENTRU DIAGNOSTICUL ABDOMENULUI ACUT

Examinarea fizică a abdomenului este o componentă esențială a tuturor examenelor fizice de rutină, reprezentând pasul cheie în evaluarea simptomelor abdominale, cum ar fi durere, distensie, organe mărite, sau mase.

Pregătirea pacientului

Un aspect important în asigurarea unui rezultat de succes al acestei manevre îl constituie informarea pacientului cu privire la ce se va face. Abordarea pacientului depinde în mare măsură de vârsta acestuia.

Prezența părinților în sala de examinare este benefică pentru copil, iar pentru a examina un sugar sau copil mic se poate recurge la poziționarea acestuia în poala părintelui, unde se simte în siguranță și confortabil. La examinarea copiilor mici, o altă manevră utilă este de a distra atenția copilului prin purtarea unei conversații. Întrebările despre școală, joacă, frați, familie și așa mai departe, pot distra atenția copilului de la palpate și să permită o evaluare mai exactă.

Tehnica examinării

Pentru efectuarea examinării pacientul este poziționat în decubit dorsal pe masa de examinare, cu genunchii în flexie și plantele sprijinite pe masa de examinare. Medicul se poziționează în dreapta pacientului. Este recomandat ca regiunea suspectată cu patologie abdominală (de obicei dureroasă) să fie examinată ultima pentru a obține o interpretare mai exactă a examenului abdominal.

Pentru a localiza semnelor gasite la palpate se utilizează împărțirea convențională a abdomenului în 4 cadrane (drept superior, drept inferior, stâng superior, stâng inferior) sau 9 cadrane (epigastru, hipocondrul drept, hipocondrul stâng, mezogastru, flanc drept, flanc stâng, hipogastru, fosa iliacă dreaptă, fosa iliacă stângă).

Trebuie știut care sunt aparatele și sistemele care sunt localizate anatomic în cadranele abdominale, ceea ce poate identifica corespondența organică a proceselor normale sau patologice observate.

Palparea se execută cu toată mâna, se începe cu o palpare superficială, urmată de palparea profundă. Măinile examinatorului ar trebui să fie calde.

La copiii mai mari, respirația profundă poate facilita palparea abdominală.

Patologie

În funcție de vârstă și patologie palparea abdominală poate evidenția următoarele aspecte:

Perioada neonatală și de sugar:^{5,6}

- masă în flanc unilaterală:
 - rinichi multichistic;
 - hidronefroza unilaterală;
 - tumora Wilms;
 - neuroblastomul;
 - tromboza venei renale.
- alte mase abdominale palpabile:
 - vezica urinară dilatată secundar obstrucției uretrale;
 - masele în flanc bilaterale apar în hidronefroză și rinichi polichistic;
 - duplicații ale intestinului;
 - tumori hepatice primare;
 - tumori ovariene (teratoame).
- mase palpabile asociate cu semne de obstrucție intestinală (vărsături, distensie abdominală, absența eliminării scaunului) includ:
 - masele de meconiu asociate cu anus neperforat;
 - boala Hirschsprung;
 - sindromul de dop meconial;
 - ileus meconial;
 - volvulus intestinal asociat cu malrotația intestinală;
 - invaginația intestinală.⁷

- semne de obstrucție intestinală fără o masă palpabilă:
 - atrezia sau stenoza de intestin;
 - peritonita;^{8,9}
 - enterocolita necrotizantă.

La copil și adolescent:

- detectarea defensei musculare poate fi deosebit de dificilă la un copil care plânge, nu vorbește sau se agită în timpul examinării;
- examinatorul poate încerca să surprindă scurtele perioade de relativă relaxare a abdomenului la sfârșitul expirului și începutul inspirului și poate observa eventualele grimase faciale;
- durerea la palpare în cazul unui apendice inflammat este de obicei maximă în fosa iliacă dreaptă;¹⁰
- sensibilitatea abdominală în apendicita la copii mai poate fi localizată și prin recția la decompresia bruscă în urma unei palpări profunde sau prin extensia membrului inferior când are loc compresia apendicelui pe psoas (semnul psoasului);
- date suplimentare se pot obține prin palpare abdominorectală;¹¹
- apariția musculară difuză semnifică instalarea unei peritonite generalizate.